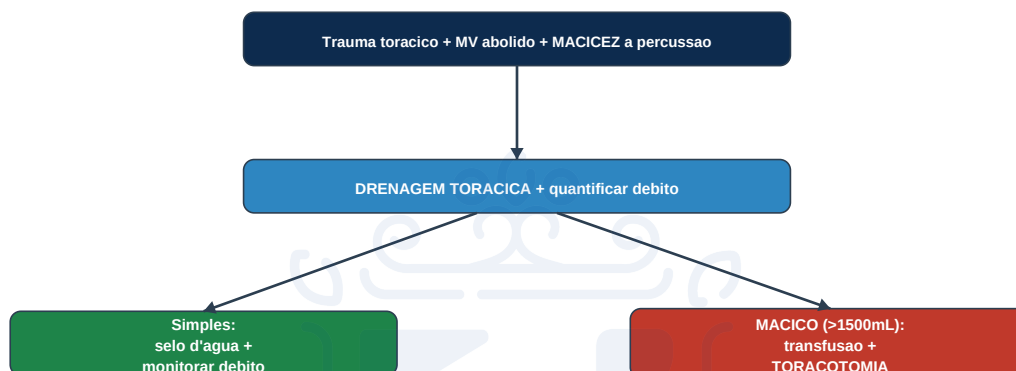


HEMOTÓRAX — DRENAR E QUANTIFICAR

FLUXOGRAMA — SIMPLES x MACIÇO

HEMOTÓRAX — DRENO É DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO



DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O QUE É

- Presença de SANGUE entre o pulmão e a parede torácica
- SIMPLES x MACIÇO (emergência cirúrgica)
- Causas: trauma contuso/penetrante; iatrogênico (toracocentese, dreno, CVC); espontâneo (raro)
- Origem do sangramento: laceração pulmonar, artéria intercostal, artéria mamária interna, vasos intratorácicos

QUANDO SUSPEITAR E EXAME FÍSICO

PISTAS

- Trauma recente (mecanismo de alta energia, arma branca/fogo) ou procedimento recente
- Dor torácica, dispneia progressiva; anticoagulante/discrasia
- Geral: palidez, sudorese, taquicardia, hipotensão, taquipneia (sinais de choque)
- Percussão: MACICEZ/submacicez (diferencia do pneumotórax, que é hipertimpânico)
- Ausculta: MV reduzido/abolido ipsilateral; pode coexistir com pneumotórax

RED FLAGS — HEMOTÓRAX MACIÇO

EMERGÊNCIA CIRÚRGICA

- Definição: > 1.500 mL de sangue na cavidade pleural
- OU após drenagem: débito inicial > 1.500 mL, ou sangramento > 200 mL/h por 2-4h
- Choque hemorrágico: hipotensão, taquicardia, palidez intensa, rebaixamento, dispneia grave
- Conduta: drenagem imediata + reposição volêmica + protocolo de transfusão maciça + TORACOTOMIA de urgência
- Drenagem NÃO é o tratamento definitivo no maciço — serve para diagnóstico, alívio e quantificação

TRATAMENTO E PRESCRIÇÃO

Rx DRENAR + SUPORTE

Hemotórax SIMPLES: drenagem torácica em selo d'água (resolve a maioria) + O2 + analgesia + monitorização
Avaliação SERIADA do débito do dreno (decide cirurgia)
O2 suplementar (SatO2 > 94%); 2 acessos venosos calibrosos
Cristaloides aquecidos com critério + hemocomponentes conforme necessidade
Analgesia (opioide se necessário); profilaxia de TEV só APÓS controle do sangramento
Antibioticoprofilaxia: avaliar caso a caso no trauma penetrante

EXAMES

ESTÁVEL x INSTÁVEL

- INSTÁVEL: NÃO atrasar o tratamento para exames
- RX de tórax: velamento do seio costofrênico, opacidade homogênea
- USG (eFAST): rápido e útil no trauma (líquido acima do diafragma)
- TC de tórax: apenas se estável (planejamento cirúrgico)
- Tipagem/prova cruzada precoce; gasometria/lactato

ERROS COMUNS A EVITAR

NÃO FAZER

- Subestimar hemotórax no trauma contuso
- Não quantificar o débito do dreno (perde o critério de toracotomia)
- Atrasar a drenagem torácica
- Manter paciente instável sem acionar o centro cirúrgico
- Aguardar TC em paciente em choque

INTERNAÇÃO E ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: todo hemotórax drenado, trauma torácico moderado/grave, risco de ressangramento, observação pós-trauma
- ☐ ALTA: assintomático, estável, DRENO RETIRADO, RX de controle satisfatório, sem sangramento ativo
- ☐ Orientações: evitar esforços; retornar se dispneia, dor torácica, tontura/síncope
- ☐ Seguimento ambulatorial definido
- ☐ Estabilizar ao máximo antes de transferir

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Hemotórax ____ (simples/maciço) pós-trauma ____ (contuso/penetrante) à ____.
- Volume drenado inicial ____ mL; débito atual ____ mL/h; estado hemodinâmico ____.
- Reposição volêmica/transfusional realizada: ____; RX/FAST: ____.
- Ex.: hemotórax pós-trauma penetrante, drenado 1.600 mL com sangramento persistente, instável -> toracotomia em terciário.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Vítima de trauma torácico penetrante, drenagem com débito inicial de 1.600 mL e sangramento persistente, instável. Qual a conduta?

- A) Manter apenas o dreno e observar
- B) Reposição volêmica/transusão + toracotomia de urgência (hemotórax maciço)
- C) Retirar o dreno
- D) Aguardar a tomografia
- E) Alta com analgésico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado ao exame físico ajuda a diferenciar hemotórax de pneumotórax?

- A) Hipertimpanismo à percussão
- B) Macicez à percussão (no hemotórax) versus hipertimpanismo (no pneumotórax)
- C) Murmúrio vesicular aumentado
- D) Sopro tubário
- E) Estertores crepitantes bilaterais

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Como se define hemotórax maciço?

- A) > 500 mL de sangue na cavidade pleural
- B) > 1.500 mL na cavidade, ou débito inicial > 1.500 mL, ou > 200 mL/h por 2-4h
- C) Qualquer hemotórax drenado
- D) Apenas se houver pneumotórax associado
- E) > 100 mL de sangue

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a drenagem torácica no hemotórax maciço, é correto:

- A) É o tratamento definitivo isoladamente
- B) Serve para diagnóstico, alívio ventilatório e quantificação; sangramento persistente indica toracotomia
- C) Está contraindicada
- D) Deve ser adiada até a TC
- E) Substitui a reposição volêmica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é um erro comum a evitar no manejo do hemotórax?

- A) Quantificar o débito do dreno
- B) Não quantificar o débito do dreno (perde o critério de toracotomia)
- C) Drenar precocemente
- D) Acionar o centro cirúrgico no instável
- E) Reservar a TC para o estável

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Débito inicial > 1.500 mL com sangramento persistente em paciente instável caracteriza hemotórax maciço: reposição volêmica/transusão maciça + toracotomia de urgência. O dreno isolado não resolve o sangramento ativo.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

À percussão, o hemotórax é MACIÇO (submacicez) pelo líquido, enquanto o pneumotórax é HIPERTIMPÂNICO pelo ar. Ambos reduzem o murmúrio vesicular ipsilateral e podem coexistir.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Hemotórax maciço = > 1.500 mL na cavidade, OU débito inicial de drenagem > 1.500 mL, OU sangramento contínuo > 200 mL/h por 2-4h — critérios que indicam toracotomia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A drenagem no hemotórax maciço é diagnóstica, alivia a ventilação e quantifica o sangramento, mas não é definitiva: sangramento persistente é indicação de toracotomia. A reposição volêmica corre em paralelo.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Não quantificar o débito do dreno é erro comum: perde-se o critério objetivo de toracotomia (> 1.500 mL inicial ou > 200 mL/h). Drenar cedo, acionar o cirúrgico no instável e reservar TC ao estável são condutas corretas.

SM24
Suporte ao Plantão Médico